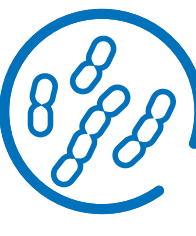


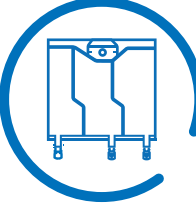
Beneficios de Fresomega®

 **Reduce significativamente la estancia hospitalaria en general ⁷⁻⁹ y la estancia post-trasplante ¹².**

 **Reduce la tasa de infecciones ^{7,10,11} y la incidencia de SIRS ^{7,8}.**

 **Modula la inflamación excesiva ^{1,3,5}.**

 **Impacto positivo en el funcionamiento de los órganos (riñón ³, hígado ^{11,12}, pulmón ³ y páncreas ¹³).**

 **Mejora el estado nutricional ^{9,11}.**

Fresomega®
Dosis recomendada:
De 1 ml a 2 ml máximo de **Fresomega®** /kg/d.

equivalente a 0.1 g a 0.2 g máximo de aceite de pescado/kg/d.



Referencias

- Morlion, B.J., et al. The effect of parenteral fish oil on leukocyte membrane fatty acid composition and leukotriene-synthesizing capacity in patients with postoperative trauma. Metabolism, 1996, 45(10): p. 1208-13.
- Roulet, M., et al. Effects of intravenously infused fish oil on platelet fatty acid phospholipid composition and on platelet function in postoperative trauma. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 1997. 21(5): p. 296-301.
- Wang, X., et al. Omega-3 fatty acids-supplemented parenteral nutrition decreases hyperinflammatory response and attenuates systemic disease sequelae in severe acute pancreatitis: a randomized and controlled study. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2008. 32(3): p. 236-41.
- Singer, P., et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin Nutr, 2009. 28(4): p. 387-400.
- Liang, B., et al. Impact of postoperative omega-3 fatty acid-supplemented parenteral nutrition on clinical outcomes and immunomodulations in colorectal cancer patients. World J Gastroenterol, 2008. 14(15): p. 2434-9.
- Han, Y.Y., et al. Effects of fish oil on inflammatory modulation in surgical intensive care unit patients. Nutr Clin Pract, 2012. 27(1): p. 91-8.
- Zhu, M.W., et al. Impact of fish oil enriched total parenteral nutrition on elderly patients after colorectal cancer surgery. Chined J (Engl), 2012. 125(2): p. 178-81.
- Jiang, Z. M., et al. Randomized clinical trial of intravenous soybean oil alone versus soybean oil plus fish oil emulsion after gastrointestinal cancer surgery. Br J Surg. 2010. 97(6): p. 804-9.
- Klek, S., et al. The clinical value of parenteral immunonutrition in surgical patients. Belg, 2005. 105(2): p. 175-9. after gastrointestinal cancer surgery. Br J Surg. 2010. 97(6): p. 804-9.
- Badia-Tahull, M.B., et al. A randomised study on the clinical progress of high-risk elective major gastrointestinal surgery patients treated with olive oil-based parenteral nutrition with or without a fish oil supplement. Br J Nutr, 2010. 104(5): p. 737-41.
- Zhu, X., et al. Effects of omega-3 fish oil lipid emulsion combined with parenteral nutrition on patients undergoing liver transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2013. 37(1): p. 68-74.
- Zhu, X.H., et al. Liver-protecting effects of omega-3 fish oil lipid emulsion in liver transplantation. World J Gastroenterol, 2012. 18(42): p. 6141-7.
- Heller, A.R., et al. Omega-3 fatty acids improve liver and pancreas function in postoperative cancer patients. Int J Cancer, 2004. 111(4): p. 611-6.
- Pradelli, L., et al. Cost-effectiveness of omega-3 fatty acid supplements in parenteral nutrition therapy in hospitals: A discrete event simulation model. Clin Nutr, 2013.
- Mayer K et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2006; 9:140-148.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA: 1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA-FRESOMEGA® 2.DENOMINACIÓN GENÉRICA: ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 3.FORMA FARMACEUTICA: EMULSIÓN 10% INYECTABLE FORMULACIÓN: Cada 100 ml contiene: Aceite de pescado altamente refinado 10.0 g que contiene: Ácido eicosapentaenoico (EPA) 1.25 - 2.82 g. Ácido docosahexaenoico (DHA) 1.44 -3.09 g. Ácido mirístico 0.1-0.6 g. Ácido palmítico 0.25-1.0 g. Ácido palmítico 0.3 - 0.9 g. Ácido esteárico 0.05-0.2 g. Ácido oleico 0.6 -1.3 g. Ácido linoleico 0.1 - 0.7 g. Ácido linoleico 0.05-0.654 g. Ácido eicosanoico 0.05-0.3 g. Ácido araquidónico 0.1-0.4 g. Ácido docosanoico ≤ 0.15 g. Ácido docosapentaenoico 0.05-0.45 g. dl-α-Tocoferol (como antioxidante) 0.015-0.0296 g. Glicerol 2.5 g. Fosfatido de huevo purificado 1.2 g. Vehículo cbp 100 ml. Contenido calórico: 470 kJ/100 ml = 112 Kcal/100 ml. pH: 7.5-8.7. Titulación de la acidez: < 1 mmol HCl/l. Osmolalidad: 308- 376 mOsm/kg. 4.INDICACIONES TERAPEUTICAS: Para suplementación de la nutrición parenteral con ácidos grasos omega-3 de cadena larga, especialmente ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico, cuando resulta imposible la nutrición oral o enteral, o es insuficiente o está contraindicada 5. CONTRAINDICACIONES: Desórdenes hemorrágicos severos. Ciertas condiciones agudas y amenazantes para la vida tales como: Colapso y choque. Infarto cardiaco reciente. Apoplejía. Embolia. Estado de coma indefinido. Debido a la falta de experiencia FRESOMEGA® no debe administrarse en pacientes con insuficiencia hepática o renal severa. FRESOMEGA® no debe utilizarse en niños prematuros, recién nacidos, infantes y niños debido a la limitada experiencia. Contraindicaciones generales de la nutrición parenteral: Hipocalcemia. Hiperhidratación. Deshidratación hipotónica. Metabolismo inestable. Acidosis. FRESOMEGA® no debe administrarse a pacientes con alergia conocida al pescado o a la proteína de huevo. 6.PRECAUCIONES GENERALES: El nivel de triglicéridos séricos debe monitorearse diariamente. Deben llevarse a cabo con regularidad revisiones de los perfiles sanguíneos de glucosa, metabolismo ácido base, electrolitos séricos, balance de líquidos, conteo sanguíneo y tiempo de coagulación en pacientes tratados con anticoagulantes. La concentración de triglicéridos séricos no debe exceder de 3 mmol/l durante la infusión de emulsiones grasas. La estabilidad química y física en uso de las mezclas que contienen FRESOMEGA® se ha demostrado durante 24 horas a 25°C y hay datos disponibles del fabricante. Desde un punto de vista microbiológico, las mezclas con emulsiones grasa o con emulsiones grasa que contienen vitaminas liposolubles deben utilizarse inmediatamente. Si no se utilizan inmediatamente, el tiempo de almacenamiento en uso y las condiciones previas al uso son responsabilidad del usuario. Solamente si la mezcla se ha llevado a cabo en condiciones asepticas controladas y validadas, las condiciones de almacenamiento pueden basarse en los datos de estabilidad del fabricante. Desde un punto de vista microbiológico, las mezclas hechas en condiciones no controladas y no validadas deben utilizarse normalmente dentro de 24 horas, incluyendo el tiempo de infusión. FRESOMEGA® debe administrarse con precaución a pacientes con metabolismo lipídico deteriorado y diabetes mellitus inestable. Usar solamente si la emulsión es homogénea y el envase no está dañado. Debe utilizarse cuando esto sea posible, con equipo de administración sin fialato. Cualquier porción del contenido así como restos de mezclas después del uso deben desecharse. FRESOMEGA® debe utilizarse inmediatamente después de romper el sello del frasco. 7.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No hay evidencia de la seguridad de este medicamento durante el embarazo y lactancia. Por lo tanto, el medicamento no debe utilizarse en el embarazo y lactancia. 8.REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La infusión de FRESOMEGA® puede conducir a tiempos de sangrado prolongados y a una inhibición de la agregación plaquetaria. En casos raros los pacientes pueden experimentar un sabor a pescado. Efectos no deseados observados durante la administración de emulsiones grasas: Ligero aumento en la temperatura corporal. Sensación de calor y/o sensación de frío. Escalofrío. Enrojecimiento o cianosis. Falta de apetito, náusea, vómito. Disnea. Dolor de cabeza, dolor en pecho, espalda y espalda baja, dolor de huesos. Priapismo (en casos muy raros). Aumento o disminución de la presión sanguínea. Reacciones anafilácticas (por ejemplo, eritema). Deben vigilarse posibles signos de sobrecarga metabólica. La causa puede ser genética (metabolismos especialmente diferentes) y con respecto a las distintas enfermedades previas con rapidez variable y después de diferentes dosis, pero ha sido observada principalmente con el uso de emulsiones de aceite de semilla de algodón. La sobrecarga metabólica puede originar los siguientes síntomas: Hepatomegalia con o sin ictericia. Cambio o reducción de algunos parámetros de la coagulación (por ejemplo, tiempos de sangrado, tiempos de coagulación, tiempos de protrombina, recuento plaquetario). Esplenomegalia. Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Tendencia a sangrado y hemorragias. Pruebas de la función hepática patológica. Fiebre. Hiperlipidemia. Dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga. Hiperlipidemia. Si se presentan estos efectos colaterales o si el nivel de triglicéridos durante la infusión lipídica aumenta por arriba de 3 mmol/l, la infusión lipídica debe suspenderse, o si es necesario, continuarse a una dosis reducida. 9.INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La infusión de FRESOMEGA® puede provocar tiempos de sangrado prolongados, inhibición de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, FRESOMEGA® debe administrarse con precaución a pacientes que requieren terapia con anticoagulantes incluso con la posible reducción de anticoagulantes. Incompatibilidades. Las incompatibilidades pueden ocurrir a través de la adición de cationes polivalentes, por ejemplo calcio, especialmente cuando se combina con la heparina. FRESOMEGA® puede ser mezclado asepticamente con emulsiones grasas así como con vitaminas liposolubles. Cuando se administra simultáneamente con otras emulsiones grasas mezcladas o diluidas antes de la administración, la porción de aceite de pescado de FRESOMEGA® debe constituir el 20 al 20% de la ingesta lipídica diaria total. Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. No aplica. 10.PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Datos de seguridad preclínica. La información preclínica no revela riesgo especial para humanos en base a los estudios convencionales de toxicidad aguda y de dosis repetida, farmacología y genotoxicidad seguros. No se han llevado a cabo estudios animales para evaluar la toxicidad reproductiva. Pruebas de sensibilización. En una prueba en conejillos de indias (Prueba de maximización), FRESOMEGA® mostró una sensibilización dérmica moderada. Una prueba de antigenicidad sistémica no indicó evidencia del potencial anafiláctico en FRESOMEGA®. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Dosis diaria: De 1 ml a 2 ml máximo de FRESOMEGA® /kg de peso corporal. Correspondiente a 0.1 g a 0.2 g máximo de aceite de pescado/kg de peso corporal. Correspondiente a 70 ml a 140 ml máximo de FRESOMEGA® para un paciente con un peso corporal de 70 kg. Velocidad máxima de infusión: La velocidad de infusión no debe exceder los 0.5 ml de FRESOMEGA® /kg de peso corporal/hora. Correspondiente a 0.05 g de aceite de pescado/kg de peso corporal/hora. La velocidad máxima de infusión debe respetarse estrictamente, de otra manera puede observarse un aumento en la concentración sérica de triglicéridos. FRESOMEGA® debe administrarse simultáneamente con otra emulsión grasa. En base a la ingesta diaria recomendada de lípidos totales de 1-2 g/kg de peso corporal, la porción de aceite de pescado de FRESOMEGA® debe constituir el 10 - 20% de esta ingesta. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Para infusión vía vena central o periférica. Los contenedores deben agitarse antes de usarse. Cuando FRESOMEGA® deba administrarse con otras soluciones de infusión (por ejemplo soluciones de aminoácidos, soluciones de carbohidratos) mediante una vía de infusión común (bypass, tubo Y), debe asegurarse la compatibilidad de las soluciones/emulsiones utilizadas. Duración de la administración: La duración de la administración no debe exceder 4 semanas. 12.MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: La sobredosis que produce un síndrome de sobrecarga de grasa puede presentarse cuando el nivel de triglicéridos durante la infusión lipídica aumenta por arriba de 3 mmol/l, de manera aguda, como resultado de una velocidad de infusión muy rápida, o de manera crónica, a velocidades de infusión recomendadas en asociación con un cambio en la condición clínica del paciente, por ejemplo, daño o infección renal. La sobredosis puede producir efectos colaterales. En estos casos, la infusión lipídica debe suspenderse o, si es necesario, continuarse en una dosis reducida. La administración de grasa también debe suspenderse si se presenta un aumento notable en los niveles sanguíneos de glucosa durante la infusión de FRESOMEGA®. Una sobredosis severa de FRESOMEGA® sin la administración simultánea de una solución de carbohidratos, puede conducir a acidosis metabólica. 13.PRESENTACIONES: Caja de cartón con 10 ampollitas de vidrio con 10 ml. Caja de cartón con 1 frasco ampolla con 50 ml ó 100 ml. 14. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Conservarse a temperatura ambiente, a no más de 25°C. 15.LEYENDAS DE PROTECCIÓN: FRESOMEGA® no debe utilizarse después de la fecha de caducidad. FRESOMEGA® debe utilizarse inmediatamente después de romper el sello del frasco. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo. No se administre si la emulsión no es homogénea o el envase está dañado. Si no se administra todo el producto, deséchese el sobrante. No se administre si el cierre ha sido violado. Agítase antes de usarse. Conservarse a temperatura ambiente, a no más de 25°C. 16. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Hecho en Austria por: Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055, Graz Austria. Acondicionado y Distribuido por: Fresenius Kabi México S.A. de CV., Av. Paseo del Norte No. 5300-A, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, México. 17.NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: REGISTRO No. 545M2000 SSA, IV.



Fresenius Kabi México S.A. de C.V.
Paseo del Norte 5300-A
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan, Jalisco, C.P. 45010
Servicio al Cliente:
800 112 2212.
www.fresenius-kabi.com.mx

NP FSMG 10/2024 V-01
Aviso COFEPRIS No.

El uso de este material es exclusivo para la distribución digital, quedando prohibida su impresión.



Fresomega®

Mejor nutrición...
Mejores resultados



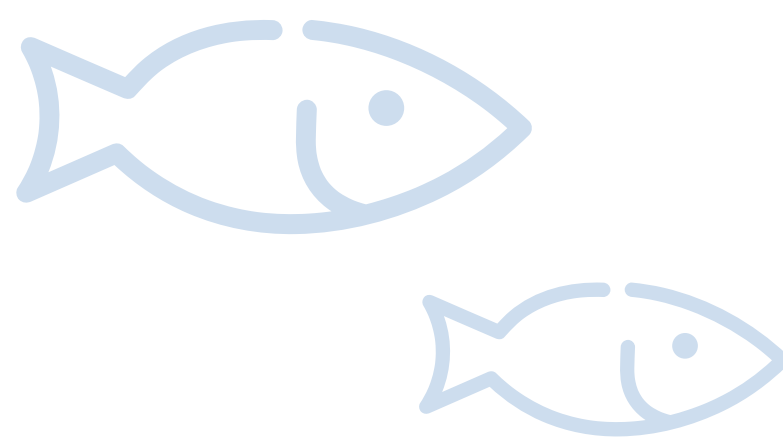
Fresomega®

Suplemento a base de aceite de pescado
único en su clase

- ✓ Rico en ácidos grasos ω -3, EPA y DHA (eicosapentanoico y docosahexaenoico).
- ✓ Mejora la nutrición clínica tradicional mediante la optimización de la relación ω -6: ω -3 ^{1,7}.
- ✓ Asegura la rápida inclusión y enriquecimiento con ω -3, los fosfolípidos plasmáticos ^{1,3} y las membranas celulares ^{1,2}.
- ✓ Influencia benéfica sobre la respuesta inflamatoria ^{1,3, 5-7}.



✓ Enriquece la Nutrición Parenteral

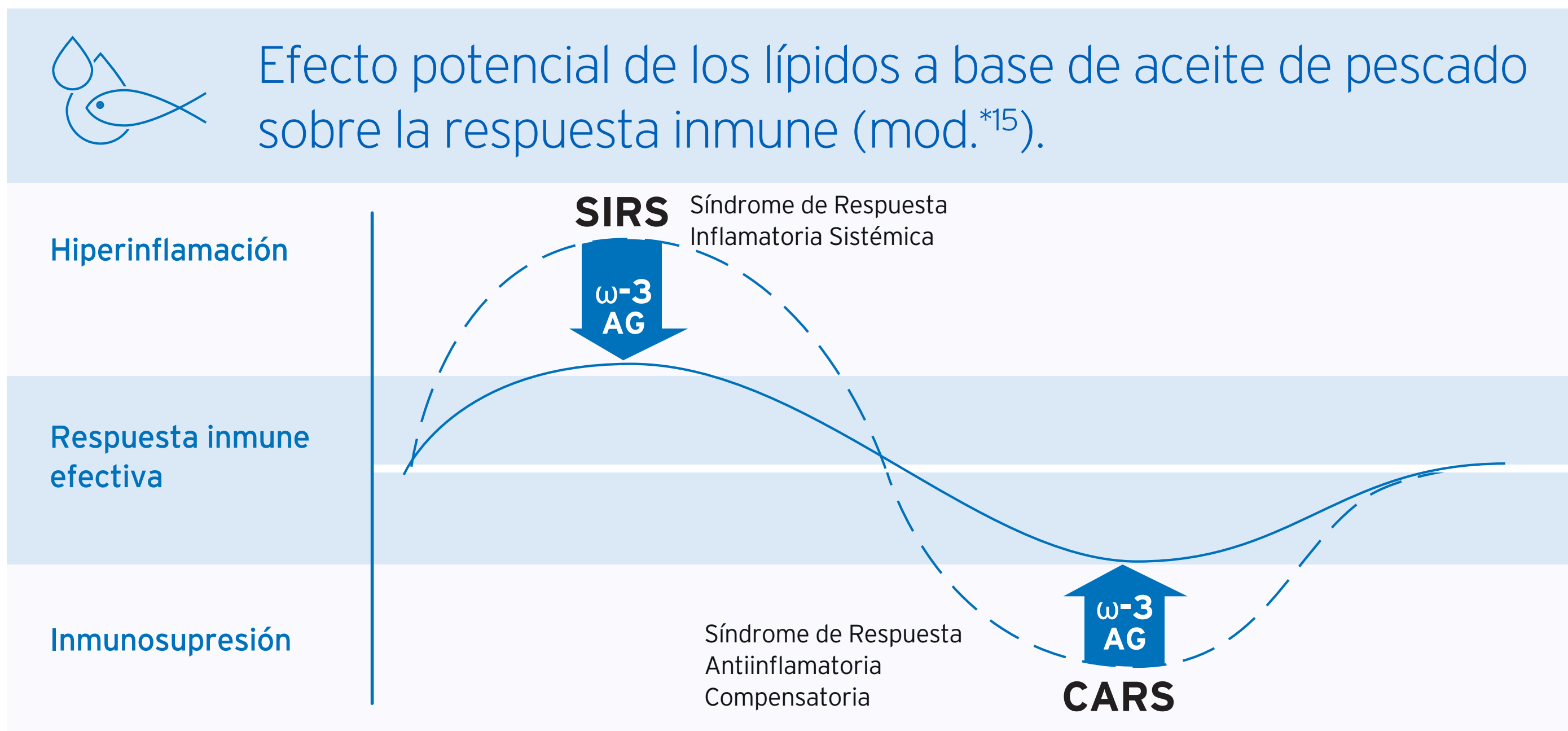


Ventajas

de complementar la nutrición con **Fresomega®**

Las emulsiones de lípidos que contienen omega-3 puro de pescado pueden proteger contra una respuesta inflamatoria excesiva ¹⁵.

- Respuesta inmune efectiva ¹⁵.
- Estimula la recuperación por la modulación de la respuesta inflamatoria ¹⁵.



Fresomega® enriquece la nutrición parenteral

- Puede administrarse en combinación con emulsiones de lípidos LCT y MCT/LCT.
- Permite lograr la relación óptima de ω -6: ω -3 4:1 a 2:1.
- Mejora la nutrición parenteral estándar.

Ejemplos de combinación de Fresomega® con emulsiones de lípidos tradicionales para lograr la relación ideal ω -6: ω -3.

Fresomega®	Emulsiones LCT * (7:1)		Emulsiones MCT/LCT * (7:1)	
	10%	20%	10%	20%
100 ml	500 ml	250 ml	500 ml	250 ml

LCT= Triglicéridos de cadena larga, MCT/LCT= Triglicéridos de cadena media / Triglicéridos de cadena larga
*= LCT emulsión de aceite de soya (ω -6: ω -3 relación de ácidos grasos).

Experiencia clínica

de nutrición parenteral enriquecida con **Fresomega®**

- ✓ **Reducción de la estancia hospitalaria general y post-trasplante**
 - Estancia hospitalaria más corta en pacientes quirúrgicos comparado con el grupo que recibió NP con LCT ó MCT/LCT.
 - Menos días de estancia en el hospital posterior al trasplante hepático comparado con el grupo que recibió NP con MCT/LCT.

Reduce la tasa de infecciones y SIRS

- Menor **incidencia de infecciones** en pacientes de cirugía oncológica ⁸ y general ^{10,11}.
- Reduce la incidencia de SIRS en pacientes de cirugía oncológica comparado con pacientes que no recibieron ω -3.

Modula la inflamación excesiva

- Cambio en la producción de eicosanoides y citocinas favorables para modular la **respuesta inflamatoria** de pacientes críticos y quirúrgicos:
 - Aumento de leucotrienos LTB₅ y LTC₅ de menor potencial inflamatorio en pacientes post-quirúrgicos de trauma en comparación con el grupo control que recibió NP a base de aceite de soya.
 - Reducción de los monocitos generadores de citocinas proinflamatorias, como IL-6 ⁵⁻⁷ y factor de necrosis tumoral (TNF) - α ^{6,7} en pacientes de la UCI ⁶ y fuera de la UCI ^{5,7}, en comparación con grupos control que recibieron NP con emulsión de MCT/LCT o aceite de soya ^{5,7}.
 - Reducción de la proteína de fase aguda, **proteína C-reactiva (PCR)** en pacientes con pancreatitis aguda grave en comparación con el grupo control que recibió PN a base de aceite de soya ³.

Mejora de la función orgánica (riñones, hígado, pulmones y páncreas)

- Impacto positivo en la **función hepática** evidenciado por la reducción de marcadores indirectos de función hepática, AST, ALT, bilirrubina y LDH en pacientes quirúrgicos que recibieron NP enriquecida con aceite de pescado ¹³.
- Reducción de la **sesión hepática** determinada por regulación de marcadores ALT y examen histológico favorable en pacientes sometidos a trasplante hepático comparado con el grupo control que recibió NP con MCT/LCT o dieta oral ¹¹.
- Efecto favorable sobre la **función pancreática** con reducción significativa de la lipasa en pacientes quirúrgicos que recibieron NP con lípidos tradicionales ¹³.
- Mejoría significativa de la **función respiratoria**, mejor índice de oxigenación después de cinco días en pacientes con pancreatitis grave ³.
- Reducción del **daño renal** indicado por un número significativamente menor de días con terapia de reemplazo en pacientes con pancreatitis grave en comparación con el grupo que no recibió omega-3.

Mejora el estado nutricional

- Mejor índice pronóstico y prealbúmina en pacientes de **trasplante hepático** ¹¹.
- Incremento de los **niveles de prealbúmina** en pacientes quirúrgicos vs el grupo que solo recibió MCT/LCT ⁹.